

Deux techniques. Une technique purement mécanique, de libérer cet espace-là. Et deuxièmement, une technique globale de diaphragme, qui est excellente à faire chez les enfants, chez les bébés, chez n'importe qui, pour redonner une expansion. Et là, je vous guide avec une pratique du type biodynamique. On va travailler sur cette jonction oesophagienne et diaphragmatique. Il y a quand même pas mal de réseaux nerveux, tu vois, et on a quand même des zones importantes avec le tronc vagus qui est ici, tu vois. Et donc on va quand même faire sans forcer. En même temps, le fait de libérer cette zone, vous libérez toute une zone vagale. On voit ici bien la portion diaphragmatique droite et la portion diaphragmatique gauche. On voit bien ici. ce qu'on appelle la plèvre, Pleuvre ! je vais voir qui est ici. Et puis ici, on a ce qu'on appelle un reliquat, qui était à un moment donné une veine, qu'on appelle la veine de Tretz et Lehmer, qui sont ici, tu vois. Puis ici, on a une zone qu'on appelle un petit muscle, qui s'insère sur le diaphragme ici, tu vois, là, comme ça, et sur le péritoine, et qui forme ce qu'on appelle un espace périoesophagien, qui est une zone d'adaptabilité, de rééquilibrage par rapport à cette jonction diaphragmatique qu'on retrouve ici, qui se continuera après avec le muscle de Tretz, qui est le ligament suspenseur du diodénome numéro 3-4. Le corps, il s'organise souvent en forme spiralée. La spirale, c'est quelque chose de fort, il y a plein de spirales dans le corps. L'embryon, il se développe dans un mouvement. on utilise les spirales pour avoir plus de force, et bien à ce niveau-là, c'est un mouvement de spirale ici. Polarité, la spirale, en énergétique, on utilise les spirales pour aller dans les points. Je viens me mettre... Au niveau de la jonction, tu vois, où je peux avoir l'accès sur la partie la plus haute que je peux avoir sur l'estomac, tu vois. Et puis je descends, je la fais descendre. Je vais juste te demander de faire un petit test avant, c'est de tourner ta tête vers la gauche. Tu sens la sensation, ok ? Tu reviens, tourne la tête à droite, tu reviens, tu

tourne la tête à gauche, elle est limitée à gauche. Très souvent, cette zone ici empêche d'avoir une bonne rotation de la nuque. Donc je vais me mettre ici, et je vais la laisser tomber en arrière vers moi. Tu te laisses tomber, comme ça, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Voilà, tout mou, voilà, je la laisse encore, je suis fort. Sois confiant, voilà, voilà, encore, laisse-toi aller, la tête aussi, comme ça, voilà, tout mou. Et là je vais garder un point d'appui avec mon pouce, ok ? Mais tout mou, je la laisse aller, et je vais commencer à descendre ici. Je descends, je vais un peu plus en profondeur, je cherche, je descends, voilà, je l'ai, je descends, doucement, j'écoute les tissus. Voilà, par exemple ici, toi, je dois aller un peu comme ça. Et ça, on nous montre. J'observe sa respiration, à l'expiration, j'accumule un peu, je descends, je bute un petit peu, c'est un petit peu dur. Maintenant je vais tout doucement, je prends bien un point d'appui postérieur, bien droit, pour être bien stable. Regarde mes points ici, si ça te fait pas mal, ça va. Elle va tout doucement, tout doucement, je garde un peu de crédit parce que j'ai le vêtement, je redescends, là, hop, voilà, je vais lui demander tout doucement de se redresser, tout doucement, tout doucement, pour le moment ça va, stop, tu relâches, j'ai tout d'un coup le hop qui remonte avec moi, tu te laisses aller, voilà, je gagne, tout doucement, cherche, ok, je tiens, tu remontes, encore, encore, stop, tu relâches, tu te laisses un peu plus, voilà, je gagne, tu te laisses aller, tu te laisses aller, je gagne, il va, tu remontes, Amen. Tu grandis, stop, tu relâches, relâche-toi, relâche-toi, relâche-toi, j'ai un frein, je vais aller chercher un peu plus loin, je remonte, je redescends. C'est douloureux, ça remonte vers la physique. Tu remontes, tout doucement, tu grandis. Voilà, tu grandis, voilà. Je vais prendre la partie postérieure, entre les deux mains. Je t'essaie d'en arriver. Laisse-toi vraiment relâcher, s'il te plaît. Ça va, ça ne fait pas trop mal ? Le véhicule ne parle pas. Tu sens encore ou pas ? Voilà, ça vient de se ressentir. Puis ça s'ouvre au niveau de la visique.

Voilà, ça vient de passer. Voilà, très bien, tu as senti le bruit. Oui, oui. cherché par un appui postérieur et on revient là tu tournes la tête à la gauche Dans ce problème diaphragmatique, je vous ai expliqué qu'il y avait cette arrière-cavité des épiplomes, vous vous souvenez de ça ? L'arrière-cavité des épiplomes, il y avait ces insertions oesophagènes, etc. Et là, on va faire une technique où on va aller vers... N'oubliez pas que pour avoir... Vous vous souvenez des côtes, l'importance des côtes avec ce diaphragme. Eh bien, là, il y a une concentration importante à ce niveau-là. Eh bien, c'est une technique toute simple. On va venir là où le trou se fait. Vous voyez un petit trou là ? Là, je viens ici et je dépose ma main. à plat comme ça, tu vois, et je vais vers la jonction, vers les côtes, au niveau de 7, 8, 9, là, tu vois, quelque chose comme ça. Je glisse ma main ici en dessous, et je la dépose, je la mets vraiment à plat, tu vois, puis je viens avec ma main ici, comme ça. Et là, je relâche, je relâche comme ça, je fais comme ça. Tu vois, là j'ai un petit bras de levier. Et ça c'est une zone vraiment importante, c'est un carrefour important de tension. On peut relâcher. Ça va relâcher toute la jonction estomac-cardiaque. Ça va relâcher aussi toute la zone musculaire de traite, etc. Et surtout cette relation. Et là, elle va sentir, maintenant je vais me mettre plus sur un, une autre sensation, tu vois. Je vais chercher dans la globalité. Voilà, là je touche tout le corps maintenant. Vous avez la poche rétro-gastrique qui est très importante à mobiliser. Souvent les ulcères sont postérieures et tu as la poche rétro-gastrique, donc l'espace postérieur de l'estomac, qui a besoin en fait d'avoir cette mobilité pour avoir un bon péristaltisme. Pour avoir une bonne fonction. BOUM Elle doit être libre. Si elle n'est pas bien libre, elle ne s'est pas libérée par rapport au diaphragme. Les oesophages et l'estomac sont les premiers qui sont en rapport avec la base du crâne. Et puis ils ont cette relation avec le mésogastre postérieur, avec la horne et les bronches souches, gauche. Je vous donne la chaleur qui monte et puis qui redescend. Je

vais rentrer maintenant dans un autre niveau, ça c'est quand je rentre dans la force du développement embryonnaire, dans l'appui, dans la puissance, j'observe la respiration, là je sais où elle en est. Je viens de passer. Je ne sais pas si vous pouvez pas se voir une différence. Je ne sais pas si vous pouvez Quand je me mets sur le plan zona, il y a un travail tout de suite facial qui a envie de donner plus d'espace entre le diaphragme et la zone pulmonaire postérieure. J'ai été amené à descendre. En même temps, il faut savoir que sur un plan péritonéal, l'organisation du péritoème, je suis sur le premier point d'appui du péritoème. Ça veut dire que l'angle colique gauche est le premier point fixe du développement global du péritoème. Donc c'est le premier point d'appui. Je vais me mettre sur ce point d'appui-là maintenant, et je me mets sur le point de mobilité. Le point le plus mobile, c'est au niveau sécum. C'est le dernier à se mettre en place. Ici j'ai un sécum, il faut voir un peu comment il est. Et entre mes deux mains, j'ai tout l'axe de rotation. Tous les mouvements du cadre colique qui s'est installé comme ça. Et le diaphragme, il travaille là-dessus. Et là-dedans, j'ai tous les espaces de type ligament falciforme. Après, tu peux choisir, tu peux choisir, le corps choisit pour toi un travail. Ici, je peux dire qu'il y a une petite tension sur le ligament falciforme, plutôt son feuillet. pas. – Sous-titrage FR 2021 Yeah ! avec parfois l'expression d'une gentille colère qui est là, qui est en vide. C'est comme si... plus son point d'appui postérieur, et en même temps, une libération ici. Et en même temps ici, voilà, c'est un travail qui se fait dans une synchronicité sur sa tente, sur sa faux du cerveau, au niveau de la Christagalie, on va travailler sur le sinus. Voilà, sa colère s'exprime pour moi, c'est mon voyage, sa colère c'est lié à une incapacité à un moment donné à s'exprimer. – Sous-titrage FR 2021 date de longtemps, le temps t'essuie ma main, ça va peut-être dégager un peu les... sur ce qu'elle n'a pas pu dire ou qu'elle avait envie de dire, mais qu'elle ne s'est même pas vue. Je viens de

saisir le protocole quand il rentre en biodynamique. Je vous remercie. Je me suis mis sur la globalité, et puis je suis rentré dans un autre, j'ai quitté la respiration thoracique, je suis rentré dans l'espace, et j'ai laissé ouvert, et puis là le corps m'a guidé, il m'a amené sur deux points d'appui. Puis ça a bougé, puis des flashes qui me sont apparus sur une tension. Puis comme je connais bien tous les synchrones, je suis parti sur un feuillet où j'ai senti des points. Je me suis laissé aller dans ma parole. C'était le moment où tu as commencé la globalité jusqu'au moment où tu as cherché la porte qui s'est ouverte. Donc dans le processus que tu nous as découvert ce matin. Je vais vous donner la clé de ça, mais je vous la donne de façon initiatique. Je plonge dans l'eau, j'écoute le mouvement, je sens le mouvement, je cherche la balance. Une fois que j'ai trouvé la pointe balance, je vais écouter derrière le silence. Avant qu'on commence, qu'on échange un petit peu de ce que vous avez ressenti de l'autre approche. Moi, quand j'ai donné le mot, et j'ai eu l'impression qu'il a été reçu, j'ai perçu plein de cellules qui se sont mises à recevoir et à échanger dans ce coup. Et c'est au moment où tu as dit, voilà, c'est bon. Je me suis dit que c'était ça. C'est ça, c'est bien. Quand toutes les cellules font chute. Très bien, dans tous les saluts. une sensation un peu similaire pareil au moment où j'ai dit le mot il y a vraiment eu un Une réponse cellulaire, quoi, un outil. Sous-titrage ST' 501 Ça s'appelle un allumage. Donc ici, l'approche, c'est qu'on va prendre le diaphragme, comme on a vu avec le récessus costopulmonaire d'hier, on va donner cet espace au diaphragme, on va venir. Mais il y a des erreurs qu'on ne doit pas commettre dans la position des mains. Je dois avoir une sensation assez équitable entre mes mains. Erreur qu'il ne faut pas commettre ici, c'est appuyer comme ça. Tu vas appuyer sur la tête. Alors ça, c'est vraiment à la longue, je peux dire, c'est horrible. Avoir un bon appui sur tes coudes, et alors, il faut imaginer que vous mangez de l'ail. Et tu prends le bon espace. C'est vraiment important de prendre un bon

espace, tu vois. Dans cette pratique, je vais vous guider dans un état méditatif. Pas ici, maintenant je vais me mettre juste dans la position. Et toi, tu essaies juste un peu à... Tu me définis un peu ton ressenti de la position. Un toucher qui est très léger, avec beaucoup de chaleur, qui est très global, mais finalement on a l'impression que c'est jusqu'au pied. Mais en même temps, j'ai vraiment cette sensation, tu vois, que je prends ce champ micro-crystallin. Toutes ces cellules, tout ce truc, ce petit réseau, tu as des cellules, tu vois. Et sur ces cellules, tu as des récepteurs. Ça fait tout un champ énorme. Par exemple, le plus grand lieu de concentration d'informations d'un champ de glycocalyx, c'est au niveau du deuxième diodénome. C'est la partie de l'intestin la plus informée. Et puis, tu as ça partout sur le corps. C'est comme un champ, tu vois, autour, qui englobe tout le truc. Ça permet de te mettre en contact, tu vois. Je vous dis de...